针刺治疗脑卒中后失语症的研究进展

沈琳
201801 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心，上海

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2024.32.004

摘　要　脑卒中后失语症(PSA)是常见的脑卒中后遗症，患者主要表现为言语功能受损，严重影响其生活质量。针刺治疗PSA的临床效果显著，包括单一治疗(体针疗法、头皮针疗法、舌针疗法等)和综合治疗(多种针刺疗法联合应用)。该文查阅了近年来针刺治疗PSA的相关研究，总结不同针刺疗法的治疗特点与优势，为临床治疗PSA提供参考。

关键词　针刺疗法；脑卒中；失语症
中图分类号　R246.6　　**文献标识码**　A

Research Progress of Acupuncture Treatment for Aphasia after Stroke

Shen Lin
Shanghai Jiading District Malu Town Community Health Service Center, Shanghai 201801, China

Abstract　Poststroke aphasia (PSA) is common sequelae of stroke. The patients mainly present with impaired speech function, which seriously affects their quality of life. Acupuncture treatment of PSA has significant clinical effects, including single treatment (body acupuncture therapy, scalp acupuncture therapy, tongue acupuncture therapy, etc.) and comprehensive treatment (multiple acupuncture therapy combined application). This article reviewed the relevant studies on acupuncture treatment of PSA in recent years, summarized the therapeutic characteristics and advantages of different acupuncture therapies, and provided references for clinical treatment of PSA.

Key words　Acupuncture therapy; Stroke; Aphasia

《中国脑卒中防治报告2021》[1]显示，我国＞40岁人群脑卒中患病率约为2.19%，脑卒中是导致成年人死亡或残疾的主要原因。《中国心血管健康与疾病报告2023概要》[2]显示，我国脑卒中患者约为1 300万人，脑卒中后遗症发生率高达80%，其中脑卒中后失语症(PSA)发生率约38%[3]。PSA是由脑卒中引起的局灶性脑损伤，造成语言优势半球内相关结构网络破坏，进而导致语言理解障碍或语言功能永久性障碍，严重影响患者的生活质量。目前，临床对于PSA尚无特效药。临床研究发现，针刺疗法可有效改善PSA患者的语言功能[4]。《脑卒中中西医结合康复临床循证实践指南》[5]指出，脑卒中恢复期PSA患者在常规康复基础上应用针刺疗法，能够改善失语症状。本文总结了近年来不同针刺疗法治疗PSA的研究进展，为临床治疗PSA提供参考。

基金项目　上海市卫生健康委员会中医药科研项目(编号：2022QN036)；上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划(沪卫人事〔2023〕62号)。

PSA的中医病因病机

元代王国瑞的《扁鹊神应针灸玉龙经》中记载，“中风不语最难医，发际顶门穴要知，更向百会明补泻，即时苏醒免灾危。”中医学认为，PSA属于“舌瘖”“瘖痱”“风懿”“失喑”范畴，发病部位在脑部，与唇、舌、会厌有关。PSA的病机为肝风、火热、痰浊、瘀血等导致精气血津液代谢不畅、经脉运行紊乱，引起五脏功能失调，蒙蔽脑窍，脑脉不通，舌窍闭阻，失语。主证为舌强不能言、言语謇涩、语涩等，中医以中药和针刺治疗为主，旨在调和脏腑，疏通经络，开窍解语。

针刺治疗PSA的机制研究

中医学认为，针刺疗法能够调节脏腑、开窍醒神、疏通经络，改善PSA患者的语言功能。现代医学认为，针刺疗法能够通过调节神经递质的传递，调控脑内信号通路改善脑血流，并刺激神经细胞增殖，增强脑代谢，改善患者言语障碍[6]。近年来，神经影像学检查证实，针刺疗法可通过提高脑语言功能区的兴奋性，促进语言功能重建[7]。针刺治疗PSA的常用方

中国知网 https://www.cnki.net

法包括体针疗法、头针疗法、舌针疗法等。《中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)》[8]指出，可在康复治疗基础上结合中医手段治疗PSA。《中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)》[9]推荐，对于超早期患者(发病 < 24 h)使用药物联合针刺治疗，能够改善其失语症状，对于恢复期和后遗症期PSA患者推荐使用头针和体针疗法改善言语功能障碍。

PSA的常见针刺疗法

体针疗法：体针疗法在临床应用广泛，可通过刺激经络上的特定腧穴，运用不同的手法激发循经感传，调节气血运行，调整脏腑经络功能。张振风等[10]将PSA患者分为对照组和观察组，对照组给予圣愈汤口服，观察组在对照组基础上给予太冲、中冲、少冲、关冲四穴针刺治疗，并对中冲和关冲点刺放血，结果表明，观察组语言功能、神经功能及临床症状改善程度高于对照组。陈文雅等[11]对40例PSA患者进行言语治疗，对41例PSA患者进行言语治疗、针刺治疗联合低频重复经颅磁刺激，并取关冲、太冲、神门和中冲放血治疗。结果发现，联合治疗组磁共振波谱指标、失语程度及生活质量改善程度均高于对照组。由此可见，体针疗法疗效确切，临床主要选择四冲穴放血治疗，能够改善患者的语言功能。

头针疗法：头针疗法是基于脏腑经络理论，以毫针刺激头皮上对应大脑皮质功能的特定穴位或治疗区域，调节全身经络及气血运行，从而促进肢体及语言神经功能恢复。张建博等[12]取穴顶颞前斜线的下2/5，对42例PSA患者进行头针治疗，治疗6周后，评估患者的语言功能，并进行核磁共振波谱成像检查，发现患者语言障碍诊治系统训练评分较训练前明显提高。曹玉婷等[13]研究发现，头针疗法治疗PSA的机制可能与促进损伤弓状纤维束重塑、减轻患侧病灶水肿、提升脑白质纤维束内细胞结构的完整性及增强神经传导有关。焦氏头针作用于神经调节通路，可通过针刺头皮上脑皮质功能区域治疗不同类型的失语症。罗金发等[14]发现焦氏头针疗法对患者听、说、读、写的效果改善优于神经系统电刺激，可提高大脑语言区域的传导功能。头针疗法在中医经络理论上，与现代脑功能区域神经科学原理结合，能够显著改善PSA患者的语言功能。

舌针疗法：中医认为PSA的病位与舌相关，舌是治疗PSA的重要靶点。目前，临床治疗PSA主要采用“舌三针”疗法。“舌三针”源自靳瑞教授提出的“靳三针”疗法，主穴为上廉泉及左、右旁廉泉，三穴均位于舌根，周边分布着调控声带运动功能的神经，针刺时针尖向舌根斜刺，可刺激舌根末梢神经，促进气血循环，活舌开窍，有助于恢复语言功能。岭南“靳三针”学派的江钢辉教授对76例PSA患者实施“舌三针”治疗。对照组采用哑门、廉泉、通里传统穴位治疗，观察组采用取穴“舌三针”治疗。治疗2周后，对比两组语言功能，发现观察组治疗效果优于对照组[15]。李乃科等[16]研究发现，舌三针联合吡拉西坦可显著改善PSA患者的语言功能、神经功能及脑动力学指标。由此可见，舌针疗法的临床治疗效果较好。

联合疗法：临床常使用多种针刺疗法联合应用治疗，或联合言语康复训练、药物等进行综合治疗。石学敏[17]提出了“醒脑开窍”针刺法，可调神治神、开窍启闭，选穴以阴经穴为主，主穴取内关、三阴交、人中，辅穴取极泉、委中、尺泽，语言不利者配穴取上廉泉、金津、玉液，并采用三棱针在金津、玉液进行点刺放血，可化瘀祛痰、通窍解语。秦梦妮[18]研究发现“醒脑开窍”针刺疗法联合语言训练与单一语言康复训练比较，能更好地降低PSA患者失语严重程度，提高其言语能力，减轻神经功能损伤，改善大脑区域电活动，其机制可能与改善大脑供氧和脑血流量有关。在“陆氏针灸”学术思想基础上，采用陆氏特色针芒行气法联合弩法治疗PSA，对照组取穴百会、哑门、风池、合谷等穴位，观察组在对照组基础上增加头维、率谷、廉泉等穴位，结果发现，观察组失语严重程度与语言功能改善效果优于对照组[19]。徐琼等[20]采用“通督开喑针法”联合头针疗法治疗气虚血瘀型PSA患者，在颞前线与顶颞前斜线针刺基础上，加用人中、脑户、百会等穴针刺治疗，结果发现“通督开喑针法”可显著降低中医证候评分，提高患者的自发性语言、复述能力、理解口语能力及命名能力评分。因此，针刺疗法综合治疗的临床疗效优于单一治疗，且非针刺疗法联合针刺疗法的疗效均优于单一非针刺疗法，针刺疗法对于PSA的治疗有重要的临床意义。

PSA针刺治疗的选穴

临床治疗PSA患者的针刺疗法选穴大多以经验为主，目前暂无统一规范。《中医循证临床实践指南—中医内科》[21]推荐使用风池、翳风、廉泉、哑门等穴针刺治疗。许磊等[22]分析近22年的文献发现，PSA的临床针刺治疗以局部取穴为主，常用的穴位包括廉泉、金津、玉液。腧穴主要分布在头面颈项部，常用

中国知网 https://www.cnki.net

的经脉包括督脉、足少阳胆经、任脉等，经外奇穴、经验穴等也是常用的穴位。赵文倩等[23]通过整理古代针灸相关条文，探求选穴规律，发现针刺疗法主要选择哑门、中冲、百会3个穴位，以远端取穴为主。医生可根据中医辨证及临床经验灵活调整治疗穴位，以提高治疗效果。

结　语

PSA是缺血性卒中的常见并发症，目前暂无特效药，针刺治疗疗效确切，能够显著改善PSA患者的临床症状，促进其言语功能恢复，且不良反应较少。单一针刺疗法治疗PSA的研究较少，以多种针刺疗法联合应用或针刺治疗联合康复治疗的综合治疗为主。目前，PSA取穴标准、针刺手法量学标准尚无统一规范。针刺手法参数不同，包括针刺的用力方向、针长度、留针时间、针刺间隔周期等均会引起疗效差异。目前，PSA的相关研究以临床研究为主，且对于失语症的分类研究以运动性失语为主，动物实验研究较少，未来研究需进行多中心、大样本的随机对照试验，总结有效的取穴标准或针刺手法量学标准，为PSA的临床规范化针刺治疗提供科学依据，为PSA提供临床标准化治疗方案。

参考文献

[1] 《中国脑卒中防治报告2021》编写组,王陇德.《中国脑卒中防治报告2021》概要[J].中国脑血管病杂志,2023,20(11):783-793.

[2] 国家心血管病中心,中国心血管健康与疾病报告编写组,胡盛寿.中国心血管健康与疾病报告2023概要[J].中国循环杂志,2024,39(7):625-660.

[3] 王吉庆,王旭慧.针灸治疗中风后运动性失语的研究进展[J].中华针灸电子杂志,2021,10(3):114-117.

[4] 叶青,杨婷,周亮,等.醒神通窍针法治疗卒中后失语症的临床研究[J].浙江中医药大学学报,2021,45(9):955-961.

[5] 朱冉冉,王津翔,潘蓓,等.脑卒中中西医结合康复临床循证实践指南[J].上海中医药杂志,2024,58(6):1-11.

[6] 李笑仙,苏薇洁,俞璐,等.针刺治疗缺血性卒中后失语的机制研究[J/OL].上海针灸杂志,1-6.

[7] 谢晓慧.卒中后失语症的神经影像机制及其康复研究[D].合肥:安徽医科大学,2023.

[8] 张通.中国脑卒中康复治疗指南(2011完全版)[J].中国康复理论与实践,2012,18(4):301-318.

[9] 章薇,娄必丹,李金香,等.中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)[J].康复学报,2021,31(6):437-447.

[10] 张振风,洪帅,郭二凤,等.针刺四冲穴联合圣愈汤治疗卒中后失语症临床研究[J].新中医,2023,55(13):139-143.

[11] 陈文雅,郭培,张微微,等.针刺联合低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果[J].宁夏医科大学学报,2022,44(3):281-285.

[12] 张建博,杨虹,魏瑞鹏,等.针刺结合计算机辅助言语训练治疗卒中后运动性失语症疗效分析及机制研究[J].湖北中医药大学学报,2022,24(5):107-109.

[13] 曹玉婷,刘梦月,盛佑祥.头皮针治疗中风后失语症的弥散张量成像研究[J].广州中医药大学学报,2022,39(5):1066-1070.

[14] 罗金发,肖洪波,赖忠涛,等.焦氏头针结合言语训练对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J].安徽中医药大学学报,2021,40(2):53-57.

[15] 江钢辉,李湘力.靳氏舌三针治疗中风运动性失语症疗效观察[J].上海针灸杂志,2008(7):5-6.

[16] 李乃科,梁旺,廖嘉.靳氏舌三针联合吡拉西坦治疗中风失语症的临床研究[J].实用中西医结合临床,2023,23(19):1-5.

[17] 石学敏.“醒脑开窍”针刺法治疗中风病9 005例临床研究[J].中医药导报,2005(1):3-5.

[18] 秦梦妮.“醒脑开窍”康复方案治疗脑梗死后运动性失语的临床研究[D].天津:天津中医药大学,2021.

[19] 沈琳,陆李还,俞建锋,等.针芒行气法结合弩法治疗运动性失语的临床研究[J].上海医药,2021,42(14):23-25.

[20] 徐琼,刘建浩,王天磊,等.通督开喑针法联合头针治疗气虚血瘀型脑卒中后运动性失语症的疗效及对血清CGRP和ET水平影响[J].针灸临床杂志,2021,37(7):11-15.

[21] 中国中医科学院.中医循证临床实践指南-中医内科[M].北京:中国中医药出版社,2011:298-301.

[22] 许磊,何玲,李慧,等.基于数据挖掘的针灸治疗失语症选穴规律研究[J].中国针灸,2023,43(4):471-478.

[23] 赵文倩,李季.古代针刺治疗中风后失语的选穴规律探究[J].云南中医中药杂志,2022,43(5):58-61.

中国知网 https://www.cnki.net